



# PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

## Protocolo 11 — Dengue e Arboviroses (chikungunya, Zika; diferenciais: oropouche e febre amarela)

Classificação de risco A-D, hidratação, observação e regulação dos casos graves — cenário: pronto-socorro sem UTI própria, região DRS XIV (São João da Boa Vista)

|                             |                                                 |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Código                      | PS-ND-11                                        | Versão           | 1.0 (minuta)  |
| Elaboração                  | Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986 | Data-base        | setembro/2026 |
| Aprovação (Diretor Clínico) | _____                                           | Vigência         | ___/___/___   |
| Aprovação (Coordenação PS)  | _____                                           | Revisão prevista | ___/___/___   |

### 0. Escopo, premissas e fontes

Este protocolo orienta o plantonista do PS Natal Diegues no reconhecimento, estadiamento (grupos A–D), hidratação, observação e transferência dos pacientes com suspeita de dengue e outras arboviroses urbanas. Como o serviço **não dispõe de UTI**, o grupo D e o grupo C sem resposta são estabilizados aqui (expansão volêmica **começa aqui, nunca espera a vaga**) e regulados para hospital de referência.

**Fontes de ancoragem:** Ministério da Saúde. *Dengue: diagnóstico e manejo clínico — adulto e criança*, 6ª ed., 2024 (80 p.) — citado como [MS-DENGUE 2024, p.]; Ministério da Saúde. *Chikungunya: manejo clínico*, 2ª ed., 2024 (revisada em 2025) — [MS-CHIK 2024, p.]; OMS. *Guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever*, 2025 — [OMS 2025]; Guia de Vigilância em Saúde (edição vigente) para definições e notificação; SES-SP/CVE para situação epidemiológica.

**Convenção de confiança:** doses, volumes e critérios trazem a página da fonte. Itens marcados [VERIFICAR] devem ser conferidos antes da aprovação institucional. Nada substitui o julgamento clínico à beira-leito.

### 1. Queixa — o que o paciente refere

**Dengue:** febre alta (39–40 °C) de início abrupto, com cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, adinamia; náuseas, vômitos e diarreia pastosa (3–4 evacuações/dia) podem ocorrer; exantema maculopapular em ~50%, frequentemente ao cair a febre, com ou sem prurido [MS-DENGUE 2024, p. 12]. Queixas típicas na porta: "febre que não passa com nada", "dor atrás dos olhos", "dor no corpo inteiro", "manchas vermelhas", "coceira".

**Chikungunya:** febre súbita com **poliartralgia intensa e simétrica** (mãos, punhos, tornozelos, pés, joelhos), edema articular, dor lombar, exantema a partir do 3º–4º dia, fadiga; artralgia em >90% e frequentemente incapacitante ("não consigo pentear o cabelo", "não consigo andar"). Idosos podem ser afebris [MS-CHIK 2024, p. 11–14].

**Zika:** febre baixa ou ausente, exantema pruriginoso precoce (1º–2º dia), conjuntivite não purulenta, artralgia de extremidades, cefaleia; quadro leve na maioria [MS-DENGUE 2024, Tabela 2, p. 21].

**Oropouche e febre amarela** entram como diferenciais (seção 2.4).

**Definição oficial de caso suspeito de dengue [MS-DENGUE 2024, p. 55]**

Pessoa que viva em área com casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos **14 dias** para área com transmissão (ou presença de *Aedes aegypti*), com **febre de 2 a 7 dias** e **duas ou mais** das seguintes manifestações: náuseas/vômitos, exantema, mialgias, artralgias, cefaleia, dor retro-orbital, petéquias, prova do laço positiva, leucopenia. Também é caso suspeito **toda criança** de área com transmissão com quadro febril agudo de 2-7 dias **sem foco aparente**.

**Caso suspeito de chikungunya:** febre e artralgia ou artrite não explicadas por outras condições, residente ou visitante de área de transmissão até 2 semanas antes, ou com vínculo epidemiológico [MS-CHIK 2024, p. 24].

**2. Clínica — fases, sinais de alarme, gravidade e diferenciais**

**2.1 Fases da dengue [MS-DENGUE 2024, p. 12-18]**

| Fase        | Quando                                                  | O que acontece                                                                                                             | O que vigiar                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febril      | Dia 1 a 2-7                                             | Febre alta, sintomas gerais, exantema; viremia                                                                             | Hidratação; não usar AINE/AAS; orientar retorno no dia da defervescência                          |
| Crítica     | Início na <b>defervescência</b> (dia 3-7); dura 24-48 h | Aumento da permeabilidade capilar → extravasamento plasmático; plaquetopenia; sinais de alarme; choque entre o 4º e 5º dia | <b>É aqui que o paciente morre.</b> Reavaliação diária obrigatória; hematócrito; sinais de alarme |
| Recuperação | Após 48-72 h da fase crítica                            | Reabsorção do líquido extravasado; diurese aumenta; bradicardia; exantema/prurido tardio                                   | Hiper-hidratação iatrogênica; infecção bacteriana secundária                                      |

**2.2 Sinais de alarme — redação oficial [MS-DENGUE 2024, Quadro 1, p. 13 e p. 32]**

- Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua
- Vômitos persistentes
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)
- Hipotensão postural e/ou lipotimia
- Hepatomegalia >2 cm abaixo do rebordo costal
- Sangramento de mucosa
- Letargia e/ou irritabilidade
- Aumento progressivo do hematócrito

**Qualquer um → Grupo C.**

**2.3 Dengue grave (Grupo D) [MS-DENGUE 2024, p. 36 e p. 56]**

| Critério                                         | Como reconhecer                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Choque</b> por extravasamento grave de plasma | Taquicardia; extremidades frias; pulso fraco/filiforme; enchimento capilar >2 s; <b>pressão arterial convergente (&lt;20 mmHg)</b> ; taquipneia; oligúria (<1,5 mL/kg/h); hipotensão e cianose são <b>fase tardia</b> |
| <b>Sangramento grave</b>                         | Hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do SNC — pode ocorrer sem plaquetopenia/hemoconcentração (úlceras, AAS, AINE, anticoagulante)                                                                   |
| <b>Disfunção grave de órgãos</b>                 | Hepatite (AST/ALT >1.000), alteração de consciência (encefalite), miocardite (arritmia, alteração de ST-T, queda de FE), insuficiência renal aguda                                                                    |

**Hipotensão na dengue:** PAS <90 mmHg ou PAM <70 mmHg no adulto; queda de PAS >40 mmHg; pressão de pulso ≤20 mmHg. Em crianças até 10 anos, PAS mínima = 70 + (idade × 2) mmHg. No hipertenso, queda de 40% do nível habitual já pode ser hipotensão [MS-DENGUE 2024, p. 16 e p. 45]. O choque da dengue instala-se rápido e mata em 12-24 h, mas responde rápido a volume.

## 2.4 Populações especiais e diferenciais

| Situação                         | Particularidades e conduta                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criança (esp. <2 anos)           | Sintomas inespecíficos (sonolência, recusa alimentar, choro persistente, vômitos, diarreia); agravamento súbito, sinais de alarme menos evidentes; usar fórmula de peso e parâmetros de FC/FR/PA por idade [MS-DENGUE 2024, p. 18, Apêndices B-F]                                                           |
| Idoso (>65 a)                    | Maior letalidade; risco simultâneo de choque e de <b>sobrecarga hídrica</b> (auscultar crepitações a cada reavaliação); ajustar volumes caso a caso [p. 34, 36]                                                                                                                                             |
| Gestante                         | Letalidade superior à de não gestantes (pior no 3º trimestre); hemodiluição e taquicardia fisiológicas mascaram o extravasamento; risco de sangramento obstétrico; decúbito lateral esquerdo após 20 semanas; diferenciais: pré-eclâmpsia, HELLP, sepse. Volume de reposição igual ao dos demais [p. 52-54] |
| HAS em tratamento                | Suspender diuréticos e vasodilatadores durante hidratação venosa; ponderar betabloqueador/clonidina (rebote) [p. 44-45]                                                                                                                                                                                     |
| IC / cardiopata                  | Expansão fracionada: NYHA II → 15 mL/kg em 30 min (até 3x); NYHA III → 10 mL/kg em 30 min (até 3x); NYHA IV → UTI; monitorar congestão, diurese, perfusão [p. 46-51]                                                                                                                                        |
| Antiagregantes / anticoagulantes | Plaquetas >50.000: manter; 30-50.000: manter em observação com contagem diária; <30.000: suspender e observar até >50.000. Varfarina com plaquetas 30-50.000: internar e trocar por HNF quando INR <2; DOAC com plaquetas <50.000: internar e trocar por HNF após 24 h da última dose [p. 58-63]            |
| Oropouche (diferencial)          | Febre, cefaleia intensa, mialgia, artralgia, fotofobia, náuseas; pode recorrer após dias; casos em SP desde 2024; sem sinais de extravasamento típico — manejar como dengue até excluir; notificar                                                                                                          |
| Febre amarela (diferencial)      | Exposição a mata/área rural, não vacinado; icterícia, sinal de Faget (febre com bradicardia), oligúria, hemorragia, AST/ALT muito elevadas → <b>transferência imediata</b> , notificação em 24 h                                                                                                            |
| Outros diferenciais [p. 20]      | Leptospirose (mialgia de panturrilhas, sufusão conjuntival, icterícia, água contaminada); malária (viagem); meningococemia/sepse (púrpura, choque quente); influenza/COVID-19; hepatites; febre maculosa (carrapato); abdome agudo                                                                          |

**Regra de segurança:** nos primeiros dias, quando a distinção entre arboviroses é tênue, **conduzir como dengue** — é a de maior potencial de morte [MS-DENGUE 2024, p. 22]. Isso inclui não prescrever AINE na chikungunya aguda [MS-CHIK 2024, p. 31].

## 3. Exame físico — o que procurar [MS-DENGUE 2024, p. 24]

| Item                       | Como / o que esperar                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinais vitais completos    | T, FC, FR, PA nas duas posições (deitado e em pé → <b>hipotensão postural</b> ), PAM e <b>pressão de pulso</b> (PAS – PAD; convergente se ≤20 mmHg), SpO <sub>2</sub> |
| Perfusão                   | Enchimento capilar (normal ≤2 s; 3-5 s = choque compensado; >5 s com pele mosqueada = choque tardio); temperatura das extremidades; pulso [Tabela 1, p. 15]           |
| Consciência                | Glasgow; letargia, irritabilidade, agitação (choque tardio)                                                                                                           |
| Hidratação e diurese       | Mucosas, turgor; perguntar hora da última micção e volume (meta ≥1 mL/kg/h)                                                                                           |
| Tórax                      | Taquipneia, derrame pleural (MV diminuído em bases), respiração de Kussmaul (acidose), crepitações (sobrecarga)                                                       |
| Abdome                     | Dor à palpação, ascite, <b>hepatomegalia &gt;2 cm</b> dolorosa                                                                                                        |
| Pele                       | Exantema, petéquias, equimoses, sinal de Herman ("mar vermelho com ilhas brancas"), sangramentos                                                                      |
| Mucosas                    | Gengivorragia, epistaxe, sangramento vaginal                                                                                                                          |
| Articulações (chikungunya) | Edema articular/periarticular, tenossinovite, limitação; EVA de dor [MS-CHIK 2024, p. 28-29, 32]                                                                      |

### Prova do laço [MS-DENGUE 2024, Apêndice G, p. 76]

Calcular PAM = (PAS + PAD)/2; insuflar o manguito nesse valor por **5 min no adulto e 3 min na criança**; desenhar quadrado de 2,5 cm de lado no antebraço e contar petéquias. **Positiva: ≥20 petéquias no adulto; ≥10 na criança.** Frequentemente negativa em obesos e durante o choque. Nota: revisão sistemática OPAS/OMS 2022 mostrou baixo valor preditivo para gravidade e internação — a prova contribui para a definição de caso e para o estadiamento B, não para prever choque.

## 4. Propedêutica armada — o que esperar

### 4.1 Exames por grupo

| Grupo | Obrigatórios                                     | Recomendados                                                                                                                                                                                     | Prazo                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A     | Nenhum (a critério médico)                       | Hemograma se disponível; exame específico conforme epidemiologia                                                                                                                                 | —                                                                       |
| B     | <b>Hemograma completo</b>                        | Exames da comorbidade; hematócrito basal para comparação                                                                                                                                         | Resultado em até 2 h (máx. 4 h); paciente aguarda em observação [p. 31] |
| C e D | <b>Hemograma, albumina sérica, transaminases</b> | Glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria, TAP/TPa, RX tórax (PA, perfil, Hjelm-Laurell), USG abdome (mais sensível para derrames), ECG, ecocardiograma; exame específico obrigatório | Hematócrito em 2 h após cada etapa de expansão [p. 33, 37]              |

### 4.2 Interpretação

- **Hematócrito:** a hemoconcentração é o marcador do extravasamento; compare com o basal do próprio paciente ou com a referência por idade/sexo (mulher adulta  $42 \pm 6\%$ ; homem  $46 \pm 7\%$ ;  $>70$  anos  $41 \pm 6\%$ ; criança 5–10 anos  $37\text{--}40 \pm 4\%$ ) [Apêndice I, p. 78]. Elevação de  $\geq 20\%$  sobre o basal é o corte tradicional (OMS 2009) — o MS 2024 usa "aumento progressivo" sem número fixo. **Hematócrito em queda com choque persistente = sangramento oculto.**
- **Plaquetas:** queda progressiva na fase crítica; nadir no 4º–6º dia. Plaquetopenia isolada **não indica transfusão** nem internação por si só; a recuperação (plaquetas em elevação) é critério de alta.
- **Leucócitos:** leucopenia é típica (critério de caso suspeito); leucocitose sugere infecção bacteriana ou choque prolongado.
- **Albumina:** queda acompanha extravasamento; **transaminases:** elevação leve em até 50%;  $\text{AST/ALT} > 1.000$  = dengue grave [p. 17, 56].
- **Chikungunya:** linfopenia mais frequente que na dengue; CPK elevada se rabdomiólise; PCR/VHS elevadas; plaquetas  $< 100.000$ , ureia  $> 45$ , creatinina  $> 1,3$ , glicemia  $> 125$  e PCR  $> 3$  mg/dL associam-se a internação/óbito [MS-CHIK 2024, p. 30].

### 4.3 Exames específicos [MS-DENGUE 2024, p. 34–35, 57; MS-CHIK 2024, p. 50–51]

| Exame                                         | Janela                                   | Observações                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS1 (antígeno) — dengue                       | Até o 5º dia de sintomas                 | Positivo confirma; <b>negativo não exclui</b> (sensibilidade menor em infecção secundária). Teste rápido = triagem            |
| RT-PCR — dengue, chikungunya, Zika, oropouche | Até o 5º dia (Zika: urina até ~14 dias)  | Amostra: 10 mL adulto / 5 mL criança sem anticoagulante; $-70^\circ\text{C}$                                                  |
| IgM (ELISA)                                   | A partir do 6º dia                       | Reação cruzada entre flavivírus (dengue $\times$ Zika); confirmar em amostra convalescente se necessário; $-20^\circ\text{C}$ |
| Sorologia pareada / PRNT                      | Aguda + $\geq 14\text{--}15$ dias depois | Aumento $\geq 4\times$ nos títulos confirma                                                                                   |

**Exames específicos são obrigatórios para vigilância nos grupos C e D, mas nunca são condição para tratar** — a conduta é definida pela clínica e pelo hemograma [p. 34]. Em epidemia, o teste específico pode ser reservado a gestantes, crianças pequenas, idosos, graves e óbitos, conforme orientação da vigilância local.

## 5. Fisiopatologia

O vírus dengue (DENV, flavivírus, 4 sorotipos) é transmitido pela fêmea de *Aedes aegypti*; após 4–10 dias de incubação, a viremia coincide com a fase febril (o paciente é fonte para o mosquito — recomendar repelente). A resposta imune do hospedeiro, e não a lesão viral direta, explica a fase crítica: citocinas e ativação endotelial aumentam a **permeabilidade capilar**, com extravasamento de plasma para pleura, peritônio e interstício por 24–48 h a partir da defervescência. A hipovolemia relativa leva a choque compensado (taquicardia, vasoconstrição, PA convergente) e depois descompensado (hipotensão, acidose, CVD). A trombocitopenia decorre de supressão medular, consumo e destruição imune; as hemorragias graves resultam de vasculopatia, plaquetopenia e coagulopatia de consumo, agravadas por choque prolongado [MS-DENGUE 2024, p. 13–17, 42].

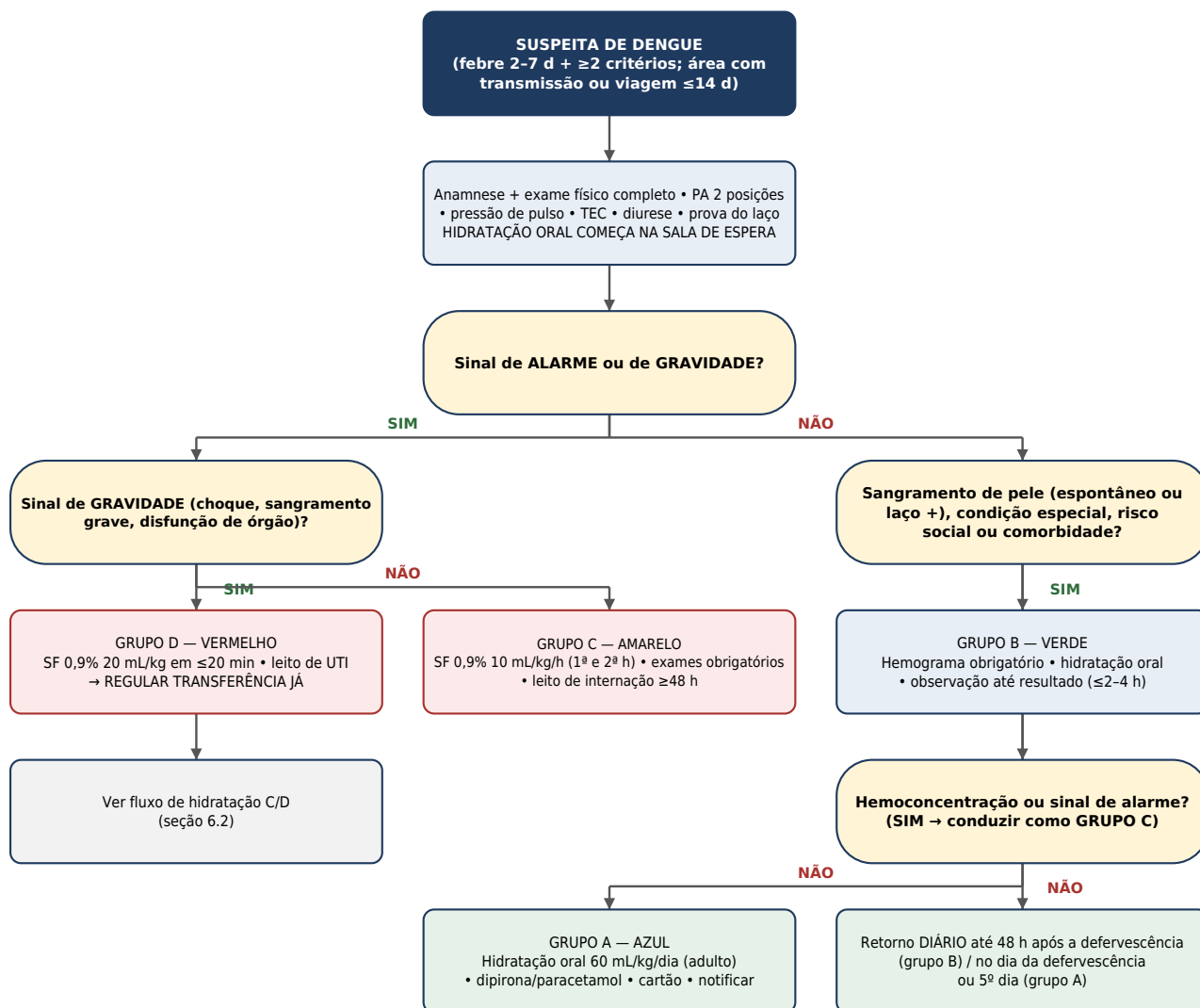
**Infecção secundária:** anticorpos heterotípicos de uma infecção prévia por outro sorotipo facilitam a entrada viral em monócitos (facilitação dependente de anticorpos — ADE), amplificando a viremia e a resposta inflamatória — por isso a segunda infecção tende a ser mais grave. A reintrodução do **DENV-3** em São Paulo (2024–2025) em população previamente exposta a DENV-1/2 aumenta o risco de formas graves na região (SES-SP/CVE, jan/2025).

**Chikungunya** (alfavírus): tropismo por sinóvia, músculo e tecido periarticular; persistência antigênica em macrófagos sinoviais explica a artrite pós-aguda e crônica (15–90 dias e >90 dias) em até metade dos pacientes; formas graves por miocardite, encefalite, nefrite e descompensação de comorbidades, com metade dos óbitos na fase pós-aguda [MS-CHIK 2024, p. 5–10, 17–20]. **Zika:** neurotropismo (Guillain-Barré; microcefalia por transmissão vertical) — gestante com suspeita exige notificação e seguimento pré-natal específico.

## 6. Fluxo de atendimento

### 6.1 Classificação de risco e estadiamento [MS-DENGUE 2024, Figura 2, p. 27; Quadro 2, p. 25]

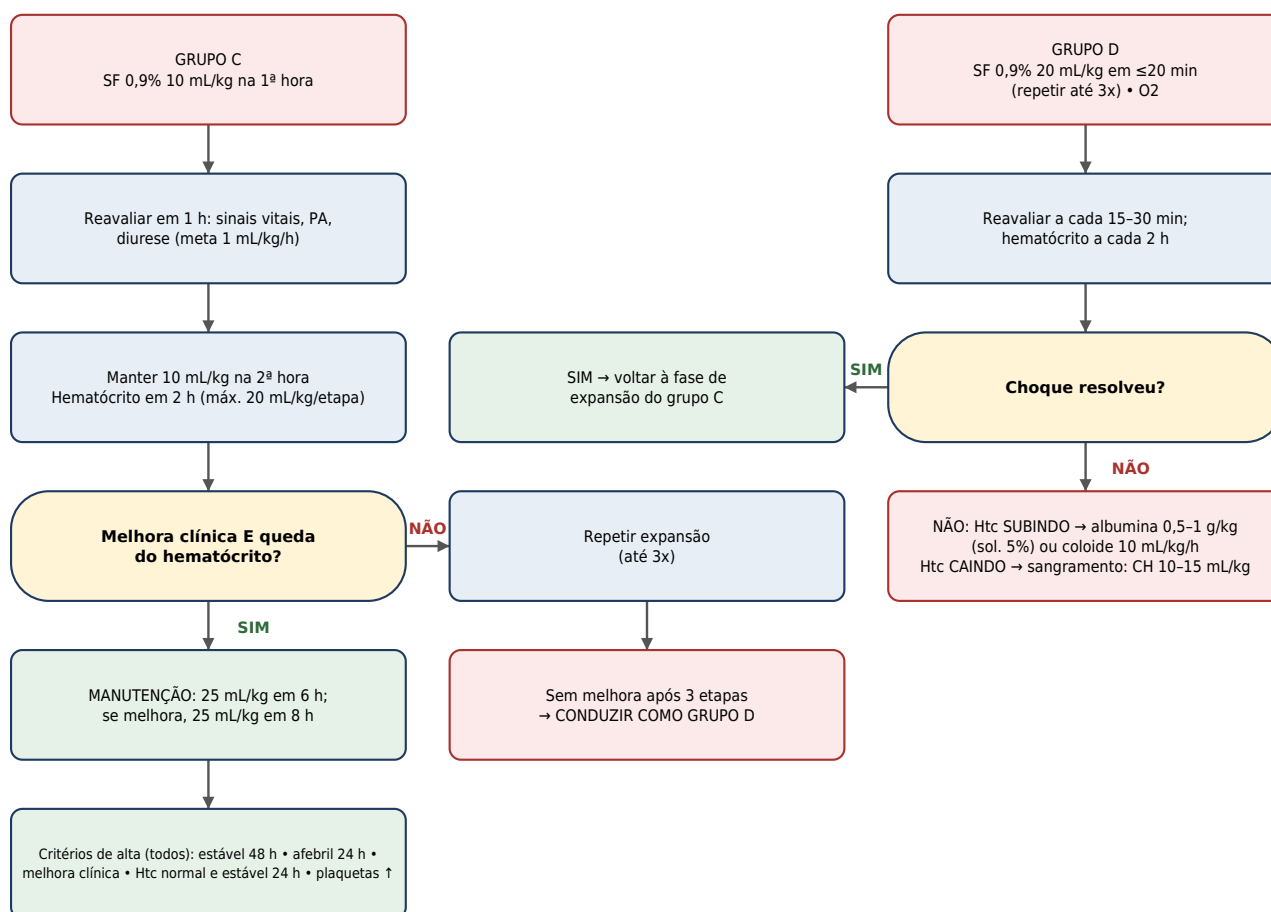
Cores da triagem: **azul** = **A** (ordem de chegada), **verde** = **B** (não urgente, mas observado), **amarelo** = **C** (urgência), **vermelho** = **D** (emergência). O paciente **muda de grupo** ao longo da evolução — reestadiar a cada reavaliação.



■ Entrada      ■ Decisão      ■ Conduta      ■ Risco / atenção      ■ Desfecho / transferência

**Condições especiais / risco social / comorbidades que definem o Grupo B** [p. 27]: lactentes (<24 meses), gestantes, adultos >65 anos, HAS ou outras doenças cardiovasculares graves, DM, DPOC, asma, obesidade, doenças hematológicas crônicas, DRC, doença ácido-péptica, hepatopatias, doenças autoimunes; impossibilidade de retorno/seguimento.

## 6.2 Hidratação venosa — grupos C e D [MS-DENGUE 2024, p. 33-39]



**Regras que não se negociam:** (1) a expansão do grupo D começa **em qualquer nível de complexidade, inclusive durante a transferência, mesmo sem exames** [p. 36]; (2) idoso e cardiopata: mesma lógica, volumes ajustados e ausculta pulmonar a cada etapa [p. 34, 36, 46-51]; (3) **interromper ou reduzir a infusão** ao mínimo quando: extravasamento cessou, PA/pulso/perfusão normalizados, hematócrito caindo sem sangramento, diurese normal, sintomas abdominais resolvidos [p. 39]; (4) O<sub>2</sub> em toda situação de choque [p. 39]; (5) OMS 2025: **crystalóide, não coloide**, como fluido de escolha; usar TEC e lactato para guiar a reposição. O MS não define preferência entre SF 0,9% e Ringer lactato no texto principal — o fluxograma cita SF 0,9%; qualquer cristalóide isotônico é aceitável, com atenção à acidose hiperclorêmica em grandes volumes.

## 6.3 Internação, alta e retorno

| Decisão                     | Critérios [MS-DENGUE 2024, p. 43]                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internar (observação/leito) | Sinais de alarme, choque, sangramento grave, disfunção de órgão (C e D); recusa de líquidos/alimentos; comprometimento respiratório; impossibilidade de retorno (clínica ou social); comorbidade descompensada (DM, HAS, IC, dicumarínico, asma, anemia falciforme) |
| Alta hospitalar (todos)     | Estabilidade hemodinâmica por 48 h • afebril por 24 h • melhora clínica visível • hematócrito normal e estável por 24 h • plaquetas em elevação                                                                                                                     |
| Retorno do grupo A          | No dia da defervescência (possível início da fase crítica) ou no 5º dia se a febre persistir; imediato se sinal de alarme [p. 28]                                                                                                                                   |
| Retorno do grupo B          | Reavaliação clínica e laboratorial <b>diária</b> até 48 h após a queda da febre [p. 32]                                                                                                                                                                             |
| Retorno após alta de C/D    | Segue a orientação do grupo B [p. 35, 39]                                                                                                                                                                                                                           |

## 7. Tratamento — doses e vias

### 7.1 Hidratação oral — grupos A e B [MS-DENGUE 2024, Quadro 3, p. 30]

| Paciente                  | Volume/dia                               | Como distribuir                                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adulto                    | <b>60 mL/kg/dia</b> (ex.: 70 kg = 4,2 L) | 1/3 como SRO, com volume maior no início (1,4 L nas primeiras 4-6 h); 2/3 restantes com líquidos caseiros (água, sucos, chás, água de coco, soro caseiro) |
| Criança (<13 a) até 10 kg | <b>130 mL/kg/dia</b>                     | 1/3 como SRO; 1/3 do volume total nas primeiras 4-6 h; manter aleitamento                                                                                 |
| Criança 10-20 kg          | <b>100 mL/kg/dia</b>                     | idem                                                                                                                                                      |
| Criança >20 kg            | <b>80 mL/kg/dia</b>                      | idem                                                                                                                                                      |

Iniciar ainda na sala de espera; manter durante todo o período febril e por 24-48 h após a defervescência; especificar o volume por escrito no cartão de acompanhamento. Soro caseiro: 1 colher de café de sal + 2 colheres de sopa de açúcar em 1 L de água [Anexo, p. 80].

### 7.2 Sintomáticos [MS-DENGUE 2024, Apêndice H, p. 77; MS-CHIK 2024, Quadro 3, p. 33-34]

| Fármaco                                   | Adulto                                                                                                                                                                                                                                  | Criança                                                                                                                           | Cautelas                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dipirona                                  | 500 mg (1 cp ou 20 gotas) até 6/6 h; chikungunya: 1-2 cp ou 20-40 gotas 6/6 h                                                                                                                                                           | 10 mg/kg/dose até 6/6 h (MS-DENGUE); 10-25 mg/kg 6/6 h (MS-CHIK). Não usar VO <3 meses ou <5 kg; não IV entre 3-11 meses ou <9 kg | Gotas 500 mg/mL (1 mL = 20 gotas); sol. oral 50 mg/mL; inj. 500 mg/mL. Evitar em G6PD; risco de hipotensão IV rápida |
| Paracetamol                               | 500 mg (1 cp ou 40 gotas) 4/4 h ou 1 g 6/6 h; <b>máx. 4 g/dia</b> (prudência: ≤3 g/dia se hepatopatia, álcool ou transaminases elevadas)                                                                                                | 10 mg/kg/dose até 6/6 h (MS-DENGUE); 10-15 mg/kg 4-6/6 h (MS-CHIK)                                                                | Gotas 200 mg/mL (1 mL = 20 gotas); hepatotóxico em dose alta — checar transaminases nos grupos C/D antes de repetir  |
| Antieméticos                              | Metoclopramida 10 mg IV/VO até 8/8 h ou ondansetrona 4-8 mg IV/VO 8/8 h                                                                                                                                                                 | Ondansetrona 0,15 mg/kg/dose (máx. 8 mg) — evitar metoclopramida <1 ano                                                           | Vômitos persistentes = sinal de alarme → Grupo C, não apenas antiemético                                             |
| Prurido                                   | Anti-histamínico (loratadina 10 mg/dia ou dexclorfeniramina 2 mg 8/8 h); banhos frios; hidratante                                                                                                                                       | Loratadina 5 mg (2-5 a) / 10 mg (>6 a)                                                                                            | Sedação com dexclorfeniramina — cautela em idoso                                                                     |
| Dor articular intensa (chikungunya aguda) | Escalonar: dipirona/paracetamol em <b>horário fixo, nunca "se necessário"</b> → codeína 30-60 mg 3-4x/dia (máx. 360 mg) ou tramadol 50-100 mg 4-6/6 h (máx. 400 mg) → ciclobenzaprina 10-40 mg à noite (>15 a) [MS-CHIK 2024, p. 32-34] | Codeína 0,5-1 mg/kg/dose 4-6/6 h (máx. 60 mg/dia); tramadol >1 a 1-2 mg/kg dose única                                             | Idoso: codeína iniciar 15 mg 4/4 h; sonolência, constipação; compressas frias e repouso                              |

**CONTRAINDICADOS em suspeita de arbovirose aguda:** AAS e salicilatos, **AINEs** (ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno etc.), corticosteroides na fase aguda [MS-DENGUE 2024, p. 28; MS-CHIK 2024, p. 31; OMS 2025 — recomendação forte contra AINE em qualquer gravidade e contra corticoide na doença não grave]. Não prescrever injeções IM desnecessárias (hematoma). Não iniciar anticoagulante profilático sem discutir com a referência. Não usar antibiótico sem foco bacteriano definido.

### 7.3 Chikungunya — fases pós-aguda e crônica (para a alta e a APS) [MS-CHIK 2024, p. 35-42]

| Fase / padrão                              | Conduta                                                                                                                                                                        | Observações                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pós-aguda (15-90 d) — dor não inflamatória | AINE por 10 dias (ibuprofeno 200-600 mg 3-4x/dia, máx. 3,2 g; ou naproxeno 250 mg 12/12 h) → se resposta, até 4 semanas com retirada gradual                                   | Só após descartar dengue e passados 14 dias; hemograma, glicemia, ureia, creatinina, transaminases antes; contraindicado no 3º trimestre, úlcera, DRC (ClCr <30), IC grave |
| Pós-aguda — artrite/tenossinovite (edema)  | <b>Prednisona 0,5 mg/kg/dia (máx. 40 mg), dose única matinal</b> , após o 14º dia; se boa resposta em 4 semanas, desmame reduzindo 1/4 da dose a cada 7 dias (total 8 semanas) | Suspensão abrupta → rebote. Respeitar contraindicações; glicemia em diabético                                                                                              |
| Dor neuropática (DN4 ≥4)                   | Amitríptilina 25-100 mg/noite (máx. 150) ou gabapentina 300 mg 3x/dia (titular; máx. 3,6 g) ou carbamazepina 200-400 mg/dia (máx. 1,2 g)                                       | Início de ação em ~2 semanas; evitar tricíclico em idoso com cardiopatia/glaucoma; gestante: evitar                                                                        |
| Crônica (>90 d)                            | Encaminhar à APS/reumatologia: hidroxicloroquina 6 mg/kg/dia (máx. 400 mg) por 8 semanas → metotrexato 7,5-25 mg/semana se falha                                               | Fora do escopo do PS; fisioterapia em todas as fases                                                                                                                       |

### 7.4 Hemocomponentes e correções [MS-DENGUE 2024, p. 38, 41-42, 63]

- **Plaquetas:** apenas em sangramento persistente não controlado após correção de fatores e do choque, ou trombocitopenia com INR >1,5× — **nunca profilaticamente por contagem baixa**. Dose: 1 U/10 kg.
- **Concentrado de hemácias:** 10-15 mL/kg/dia se hemorragia com hematócrito em queda e choque.
- **Plasma fresco 10 mL/kg, vitamina K IV, crioprecipitado 1 U/5-10 kg:** se coagulopatia documentada. Varfarina com sangramento grave: PFC 15 mL/kg até INR <1,5 + vitamina K 10 mg.
- **Albumina:** choque persistente com hematócrito em ascensão após cristalóide adequado — 0,5-1 g/kg em solução a 5% (25 mL de albumina 20% + 75 mL SF para cada 100 mL); coloide sintético 10 mL/kg/h na falta [VERIFICAR disponibilidade local].
- **Bicarbonato:** só com pH <7,20 ou  $\text{HCO}_3^- < 10$ ; sem gasometria, adulto em choque sem resposta a 2 etapas pode receber 40 mL de  $\text{NaHCO}_3$  8,4% na 3ª expansão.
- **Inotrópicos/vasopressores** (choque com disfunção miocárdica ou congestão): dobutamina 2,5-20 mcg/kg/min; noradrenalina 0,01-0,5 mcg/kg/min; dopamina 5-20 mcg/kg/min; adrenalina 0,01-0,3 mcg/kg/min [p. 40, 50] — iniciar aqui enquanto se aguarda transferência; na fase de reabsorção, **restringir** líquidos.

## 7.5 Orientações de saída e vacinação

- Entregar e preencher o **cartão de acompanhamento** (sinais de alarme em linguagem simples, volume de líquido, datas de retorno, hematócrito/plaquetas) [Anexo, p. 80].
- Retorno imediato se: dor forte na barriga, vômitos frequentes, sangramento, tontura ao levantar, sonolência/agitação, urina diminuída, suor frio, dificuldade de respirar — **especialmente no dia em que a febre baixar**.
- Repelente durante a viremia, eliminação de criadouros, repouso; manter amamentação.
- Notificação compulsória** de todo caso suspeito (Sinan) — dengue com sinais de alarme/grave e óbitos são de notificação **imediata (24 h)** à vigilância municipal; chikungunya: óbito suspeito em 24 h; Disque-Notifica 0800-644-6645 [MS-CHIK 2024, p. 52; lista nacional vigente — VERIFICAR redação para dengue].
- Vacinação:** Qdenga (Takeda, 2 doses, intervalo de 3 meses) ofertada no SUS desde 2024 para **10-14 anos**; **Butantan-DV** (dose única SC, aprovada pela Anvisa em 26/11/2025 para 12-59 anos) incorporada ao PNI em 2026, com introdução escalonada por faixa etária e não intercambiável com a Qdenga — a vacina **não é usada na fase aguda**; orientar procurar a UBS após recuperação, respeitando o intervalo pós-infecção definido pelo PNI [VERIFICAR nota técnica vigente e público-alvo local em 2026].
- Febre amarela:** Estiva Gerbi está em área com recomendação vacinal; conferir cartão do paciente e encaminhar não vacinados à UBS.

## 8. Como conduzir o caso — transferência, regulação e indicadores

### 8.1 Quem transferir e com que urgência

| Situação                                                                                                                       | Urgência                                                           | Destino                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupo D (choque, sangramento grave, disfunção grave de órgão)                                                                  | Imediata — expansão iniciada aqui, transporte com infusão em curso | Leito de UTI (referência regional)         |
| Grupo C sem melhora após 3 etapas de expansão, ou com hematócrito em ascensão apesar de volume                                 | Imediata                                                           | UTI                                        |
| Grupo C com resposta, mas sem leito de observação por $\geq 48$ h no PS                                                        | Mesmo dia                                                          | Enfermaria de referência                   |
| Gestante nos grupos C/D; criança $< 2$ anos com sinal de alarme; neonato com suspeita de chikungunya                           | Imediata                                                           | Referência obstétrica / pediátrica com UTI |
| Chikungunya grave (insuficiência de $\geq 1$ órgão) ou com manifestação extra-articular instável (miocardite, encefalite, IRA) | Imediata                                                           | UTI / referência                           |
| Suspeita de febre amarela; dengue com AST/ALT $> 1.000$ ; alteração de consciência                                             | Imediata                                                           | Referência com infectologia/UTI            |

### 8.2 Cuidados no transporte e documentação

- Unidade de Suporte Avançado (SAMU 192) com monitor, oximetria, dois acessos calibrosos (intraóssea na criança se necessário),  $O_2$ , infusão de cristalóide em bomba ou equipo calibrado; evitar procedimentos invasivos desnecessários (toracocentese, paracentese) [p. 40].
- Relatório com: dia de doença, horário da defervescência, grupo em cada reavaliação, **volumes infundidos e horários**, hematócritos seriados, diurese, medicações, exames coletados (informar se amostra específica já foi enviada ao laboratório de referência), comorbidades, anticoagulantes/antiagregantes em uso.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica**; pediatria/gestante: **Santa Casa de Mogi Guaçu — casos cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria** (rede pactuada em 04/09/2026).

### 8.3 Estrutura mínima do PS em período epidêmico

- Sala de hidratação oral na espera com SRO disponível; balança; classificação de risco de dengue pela enfermagem com as quatro cores.
- Hematócrito com resultado em  $\leq 2$  h (hemograma ou microhematócrito) — **condição essencial** para conduzir grupos B e C localmente.
- Leitos de observação para  $\geq 48$  h ou fluxo pactuado de internação; estoque de SF 0,9%/Ringer, albumina 20%, dipirona/paracetamol, SRO, repelente para dispensação.
- Comitê de investigação de óbitos por arbovirose acionado em todo óbito suspeito (amostras de sangue, urina, vísceras em até 48 h) [MS-CHIK 2024, p. 56–57].

### 8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

| Indicador                                                               | Meta             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tempo chegada → classificação de risco de dengue                        | $\leq 15$ min    |
| % de casos suspeitos com grupo (A–D) registrado no prontuário           | 100%             |
| % de grupos B/C/D com hematócrito na admissão e em 2 h após expansão    | $\geq 95\%$      |
| % de grupos C/D com expansão iniciada em $\leq 30$ min da classificação | $\geq 90\%$      |
| % de pacientes com prescrição de AINE/AAS (evento sentinela)            | 0                |
| % de casos notificados ao Sinan; % de óbitos notificados em 24 h        | 100%             |
| % de altas com cartão de acompanhamento e retorno agendado              | $\geq 95\%$      |
| Letalidade por dengue grave; óbitos revisados pelo comitê               | Registrar / 100% |

## 9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

| Tema                                                                          | Posição declarada                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo B — definição                                                           | O texto do MS 2024 (p. 31) define B por <i>sangramento espontâneo de pele ou induzido</i> ; o fluxograma (p. 27) inclui também condição especial/risco social/comorbidade. Adotadas <b>ambas</b> (qualquer uma → B), como no fluxograma oficial |
| Hemoconcentração                                                              | OMS 2009: $\geq 20\%$ sobre o basal; MS 2024: "aumento progressivo" sem número. Adotado: comparar com basal/referência por idade; $\geq 20\%$ = seguro; qualquer ascensão progressiva já orienta expansão                                       |
| Cristaloide                                                                   | MS cita SF 0,9% (e Ringer simples no cardiopata); OMS 2025 recomenda cristaloide sobre coloide sem preferir um cristaloide. Adotado: SF 0,9% ou Ringer lactato                                                                                  |
| Prova do laço                                                                 | Mantida pelo MS na definição de caso; OPAS/OMS 2022 alerta baixo valor preditivo de gravidade. Adotada como critério de caso e de grupo B, não como preditor de choque                                                                          |
| Dipirona pediátrica                                                           | MS-DENGUE: 10 mg/kg/dose; MS-CHIK: 10–25 mg/kg/dose. Adotada 10–15 mg/kg/dose como padrão institucional [VERIFICAR com a farmácia/bula da apresentação disponível]                                                                              |
| Corticoide na chikungunya                                                     | MS: prednisona 0,5 mg/kg após o 14º dia em artrite/tenossinovite; OMS 2025: contra corticoide na doença <i>aguda não grave</i> . Não há conflito real (fases distintas); adotado o MS                                                           |
| Vacinas 2026                                                                  | Faixas etárias, intervalo pós-infecção e cronograma da Butantan-DV mudam ao longo de 2026 — [VERIFICAR nota técnica PNI/SES-SP vigente]                                                                                                         |
| Notificação                                                                   | Prazo de notificação de dengue com sinais de alarme (imediata x semanal) conforme lista nacional vigente [VERIFICAR redação atual]                                                                                                              |
| Antieméticos, anti-histamínicos, doses pediátricas de ondansetrona/loratadina | Não constam dos manuais do MS — doses de prática consagrada em bula [VERIFICAR apresentações da REMUME]                                                                                                                                         |

## 10. Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Dengue: diagnóstico e manejo clínico — adulto e criança*. 6. ed. Brasília: MS, 2024. 80 p. Disponível em [bvsms.saude.gov.br](https://bvsms.saude.gov.br).
- Brasil. Ministério da Saúde. *Chikungunya: manejo clínico*. 2. ed. Brasília: MS, 2024 (ISBN 978-65-5993-705-9); versão revisada 2025.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Guia de Vigilância em Saúde*. 6. ed. Brasília: MS, 2023 (e atualizações). Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017 (Lista Nacional de Notificação Compulsória) e atualizações.
- World Health Organization. *WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever*. Geneva: WHO, 2025 (ISBN 978-92-4-011111-0).
- World Health Organization. *Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control*. Geneva: WHO, 2009. Pan American Health Organization. *Dengue: guidelines for patient care in the Region of the Americas*. 2. ed. 2016.
- Marques CDL, et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia para diagnóstico e tratamento da febre chikungunya. Parte 2 — Tratamento. *Rev Bras Reumatol* 2017;57(Supl 2).
- Bethell DB, et al. Noninvasive measurement of microvascular leakage in patients with dengue hemorrhagic fever. *Clin Infect Dis* 2001;32(2):243-253 (prova do laço).
- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo / CVE. Dengue — dados estatísticos 2026; nota sobre circulação de DENV-3 (jan/2025). Instituto Butantan / Anvisa: aprovação da Butantan-DV (26/11/2025); documentos técnicos PNI 2026.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de arboviroses (localização de página não conferida).

---

**Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986**

Responsável técnico pela elaboração